



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : تقي عبدالفتاح السيد عبدالفتاح

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الهرم

رقم البطاقة : 30009290105406 رقم التليفون : 01155250924

العمر (تاريخ الميلاد) : 29-09-2000 المهنة : ربه منزل

العنوان : -----

تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإخصائي الاجتماعي

التوقيع: (-----) المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج : الاورام [14165]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : -----

الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : ----- قسم : -----

جهة العلاج : ----- نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: تقي عبدالفتاح السيد عبدالفتاح National ID: 30009290105406	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

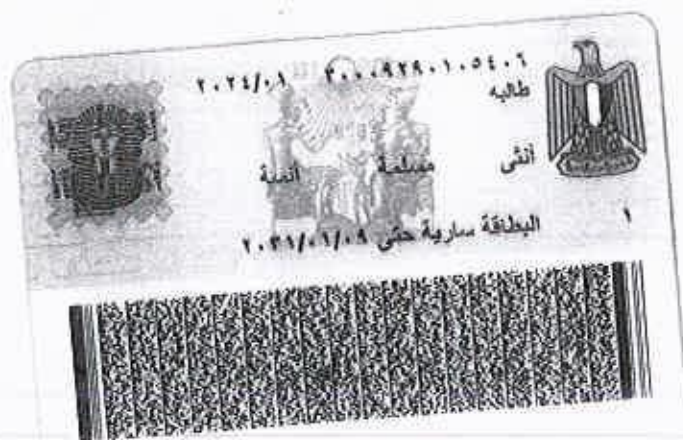
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





طاهر موفار



mm/dd/yyyy

MDT FORM

Name: Taha And Alftan	MRN: 7316
Age: 40	IN:
Menopausal Sta: premenopausal	Phone: 01155250924
NRS SCORE: 0	Marital Status: single
BMI: 0	Family History: free
Gender:	Reason Of MDT:
CO Morbidity: free	post op
Surgical History: free	ECOG Performance Status
	0 1 2 3 4

Clinical Data:

BX: IDC
ER: 8/8 PR: 5/8 HEB2: AMPLIFIE KI67:



TNM

History:
PATIENT RECIEVED 6 CYCLES TAXOTERE CARBOPLATIN
4CYCLES PHESGO
THEN OPERATED RT BCS +ALND
NO RESIDUAL TUMOUR
LN 0/22

Scintigraphy:

Biomarker/Molecular:

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan:

ypT0N0M0
Initially n2 for adjuvant phase, one year with echo and CT CAP EVERY 3
CYCLES.
PORT
ZOLDEX FEMARA
ZOMETA/ 6 MONTHS

Clinical Staging:

Pathological Staging:

ypT0 ypN0

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
------------------	---------	-----------	-----------

Handwritten signature

Patient Name	نقى عبدالفتاح السيد	Case No.	339274
Sex/Age	Female 25 Y	Patient No.	24287
Registered Date	29/6/2026 02:16:41 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	19/7/2026 10:16:29 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/7/2026 10:39:17 AM	Pathology No.	2057/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post-NACT.

Nature of specimen: Right breast wide local excision & Axillary lymph nodes dissection.

Gross Examination:

- * Right breast wide local excision specimen measured 07x06x06 cm.
- * Serialling showed a tumor bed site measured 1.0x1.0x1.0 cm, located 1 cm from the least deep margin.
- * Axillary lymph nodes: Multiple fibrofatty tissue pieces collectively measured 10x10 cm, entangling 22 lymph nodes, the largest measured 4x3x1.5 cm.
- * 14 Blocks.
- 1,2- Tumor bed site., 3- Medial margin., 4- Lateral margin., 5- Superior margin., 6- Inferior margin., 7- Superficial margin., 8 Deep margin., 9:14- ALNs.
- Gross was done by; Dr. Aya Ezzat.

Frozen (Intra-operative) Results:

- Free surgical margins

Microscopic examination:

- Histological type: No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Tumor cellularity: 0%.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Lympho-vascular emboli: Absent.
- Surgical margins: Free.
- Axillary lymph nodes: Twenty-two lymph nodes free of metastatic deposits (0/22).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.



Patient Name	نقي عبدالفتاح السيد	Case No.	339274
Sex/Age	Female 25 Y	Patient No.	24287
Registered Date	29/6/2026 02:16:41 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	19/7/2026 10:16:29 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/7/2026 10:39:17 AM	Pathology No.	2057/26

Diagnosis:

Right breast cancer (Post-NACT), Right breast wide local excision & Axillary lymph nodes dissection:

- No residual viable remnants of the previously diagnosed invasive tumor.
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Surgical margins: Free.
- Axillary lymph nodes: Twenty-two lymph nodes free of metastatic deposits (0/22).
- Histologic response to therapy: Pathological complete response to therapy.
- Stage: ypT0, ypN0.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Patient Name : **د. هبة الحسن / د. هبة الحسن**
Patient No. : **30009290103408**
Path No. : **SR-1868/25**
Sex : **Female**
Age : **25 Y**
Referring Doc :

Request No. : **13004123**
Request Date : **22/12/2025**
Verification Date : **03/01/2026**
Financial Category : **جستاف روسي - نفقة الدولة**
Department : **Out Patient**
Registered by : **marwa mohamed youss**

Pathology Report

Clinical Data

Right breast 3 o'clock mass, BIRADS 4.

Nature of specimen

Block & slide revision.

Gross examination

Two paraffin blocks (5731/25) & Seven slides were received including IPT slides
ER, PR, HER2, SISH, CK5/6 & P63.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
HER2/NEU (4B5), Ki67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination

Core (1) :

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (2+2+2) Grade 2
- * DCIS: Absent
- * Lobular intra epithelial neoplasia : Absent.
- * Angiolinvasion: Absent.
- * Microcalcification : Positive
- * Perineural invasion : Absent
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * CK5/6 & P63: Negative.
- * ER: Strong nuclear reaction in 95 % tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Strong nuclear reaction in 2% tumor cells (Allred score 5/8)
- * HER2: Moderate complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (2+)

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 11/01/2026 09:45:16

Page 1 of 3

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - شارع رقم 987 - نيل كورنيش - مصر
Room No. (4) - First Floor - Bldg No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / نقي عبد الفتاح السيد

Patient No. : 30009290105406

Path No. : SR-1868/25

Sex : Female

Age : 25 Y

Referring Doc :

Request No. : 13004123

Request Date : 22/12/2025

Verification Date : 03/01/2026

Financial Category : جوسثاف روسي - نفقة الدولة

Department : Out Patient

Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

*SISH :-Average HER2 copy No.:4.9.

-HER2/CEP17 ratio:3.9

-Core (2):

Histological type:Minimally represented Invasive duct carcinoma.

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (2+2+2) Grade 2

* DCIS: Absent.

*Lobular intra epithelial neoplasia : Absent.

* Angiolinvasion: Absent .

* Microcalcification :Absent.

*Perineural invasion: Absent.

IPT :

CK: Positive in tumor cells.

Diagnosis

RIGHT BREAST MASS, BLOCK &SLIDE REVISION

-Core (1)

-Invasive duct carcinoma Grade 2 (tubular differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)

(according to Nottingham grading system of breast cancer) ,

IPT:

* ER: Positive (score 8/8).

* PR: Positive (score 5/8).

* HER2:Equivocal (score +2)

* SISH :Amplified.

-CORE (2):

-Minimally represented invasive duct carcinoma grade II

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4,

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 11/01/2026 09:45:16

Page 1 of 3

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - ماسر القادما - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-9-27

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والإرامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
وبالبحث تبين أن

السيد (ة) تقى عبدالفتاح السيد عبدالفتاح بطاقة رقم 30009290105406
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-9-27

الموظف المختص

احمد ياسر



مسلسل 2089789

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار الإفى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول
الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-9-27

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والإرامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
وبالبحث تبين أن

السيد (ة) تقى عبدالفتاح السيد عبدالفتاح بطاقة رقم 30009290105406
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-9-27

الموظف المختص

احمد ياسر



مسلسل 2089789

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار الإفى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الإدارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول الرقمى